

[별표 6]

혈액검사 종목 및 판정기준

(제13조제2항 관련)

연번	검사 종목 ¹⁾	검사 방법 ²⁾	적합 기준 ⁴⁾	비고
1	B형간염검사	HBs Ag ³⁾	음성	-
2 ⁵⁾		HBc Ab ³⁾ 또는 HBV NAT	음성	HBc Ab 검사결과가 양성인 경우 부적합으로 판정하거나 HBV NAT 검사를 추가로 수행하여 확진함
3	C형간염검사	HCV Ab	음성	-
4		HCV NAT	음성	-
5	후천성면역결핍증 검사	HIV 1/2 Ab ³⁾	음성	-
6		HIV NAT	음성	-
7	매독검사	Syphilis (RPR 등)	음성	양성인 경우 FTA-ABS를 추가로 수행하여 확진함

주: 1. 수입 인체조직의 경우 해당 국가의 유행률 등을 고려하여 HTLV 등 검사종목을 추가로 요구할 수 있다.

2. 검사방법의 약어는 다음과 같다.

HBs Ag: Hepatitis surface antigen, HBc Ab: Hepatitis core antibody,
HBV: Hepatitis B virus, NAT: Nucleic acid amplification test, HCV: Hepatitis C virus,
HIV 1/2: Human immuno-deficiency virus type 1 and 2, RPR: Rapid Plasma Reagin,
FTA-ABS: Fluorescent treponemal antibody absorption,
HTLV: Human T-lymphotropic virus

3. HBs Ag, HCV Ab, HIV 1/2 Ab 검사방법은 효소면역측정법(EIA) 또는 이와 동등 이상의 감도를 가진 시험방법이어야 한다.

4. 조직 기증자의 혈액검사는 7가지 검사가 모두 음성인 경우에 적합한 것으로 판정한다.
만약 HBc Ab 검사결과가 양성인 기증자는 추가 HBV NAT 확진검사에서 음성 결과인 경우 적합한 것으로 보며, 매독검사시 RPR 등에서 양성인 경우에는 FTA-ABS 검사를 추가로 수행하여 매독 감염여부를 최종 확인해야 한다.

5. 2번 검사는 HBc Ab 검사 또는 HBV NAT(핵산증폭검사) 중 하나를 선택하여 수행할 수 있다. 다만 NAT 검사 없이 HBc Ab 검사만을 한 경우에는 HBV 잠복기(window period)를 고려하여 검사 90일 후 기증자의 혈액검체를 확보하여 재검사하여야 하며, 재검사를 실시할 수 없는 뇌사 및 사후 기증자의 경우에는 반드시 HBV NAT 검사를 수행하여야 한다.